Клинические рекомендации

ОРВИ у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B34.0** — Аденовирусная инфекция неуточненная **B34.2** — Коронавирусная инфекция неуточненная **J00** — Острый назофарингит (насморк) **J04.1** — Острый трахеит **J06.0** — Острый ларингофарингит **J06.8** — Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации **J06.9** — Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная **J39.9** — Болезнь верхних дыхательных путей неуточненная
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 02.09.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Союз педиатров России; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии; Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/25_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология 3

2.3 Тяжесть 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 5

3.1 Осмотр 5

3.2 Отоскопия 6

3.3 Экспресс-тесты и ПЦР 6

3.4 Анализы крови и мочи 6

3.5 Рентгенография 6

3.6 Пульсоксиметрия, ЭКГ, ЭЭГ 7

3.7 Консультации 7

4. Лечение 7

4.1 Нос и горло 7

4.2 Лихорадка 8

4.3 Кашель 9
4.4 Противовирусные препараты 9
4.5 Антибиотики 10
4.6 Иное лечение 10
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 11
5.1 Показания к госпитализации 11
5.2 Осложнения 12
5.3 Профилактика 12
6. Источник и актуальность 13
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 13

1. Основные положения

- ОРВИ: самая частая острая инфекция дыхательных путей, в большинстве случаев проходит сама. Клиника практически не зависит от возбудителя; лечение — облегчение симптомов. Изменение цвета слизи из носа на жёлто-зелёный — не признак бактериальной инфекции.
- Детям с ринитом и лихорадкой — отоскопия. Рентгенографию пазух **в первые 10–14 дней** не делают. Бактериальный синусит заподозрить при заложенности **более 7 дней** и второй волне температуры; отит чаще **на 2–5-е сутки**.
- Промывания носа, сосудосуживающие **не более 5 дней**, при лихорадке парацетамол или ибупрофен (оба **с 3 месяцев**). Антибиотики при неосложнённой ОРВИ не назначают, в том числе при риносинусите, ларингите, крупе, бронхите в первые 10–14 дней.
- Госпитализация: дети **до 3 месяцев** с фебрильной лихорадкой и дети любого возраста с опасными признаками — отказ от питья, вялость, дыхательная недостаточность, цианоз, тяжёлое обезвоживание, лихорадка **более 4–5 суток**, геморрагический синдром.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

ОРВИ — самая частая острая инфекция дыхательных путей; в большинстве случаев проходит сама и специфического лечения не требует.

Проявления катарального воспаления

1. лихорадка;
2. ринит, чихание;
3. кашель;
4. боль в горле, осиплость;
5. нарушение общего состояния.

Нозологические формы

1. острый ринофарингит;
2. острый фарингит;
3. острый трахеит;
4. острая инфекция верхних дыхательных путей неуточнённая.

ОРИ без установленной этиологии (вирусная и (или) бактериальная) раньше называли ОРЗ.

2.2 Этиология

Возбудители — преимущественно вирусы: одновременно циркулируют десятки, но клиника от этиологии почти не зависит, и диагноз должен отражать нозологическую форму.

Передача: чаще самоинокуляция на слизистую носа или конъюнктиву с загрязнённых рук и поверхностей, а также воздушно-капельно. Инкубация **2–7 дней**; пик выделения вируса на 3-и сутки, слабое выделение **до 2 недель**.

Симптомы — реакция иммунной системы; цвет назального секрета меняется на бело-жёлтый или зеленоватый из-за лейкоцитов, поэтому считать его признаком бактериальной инфекции безосновательно. «Вирусно-бактериальная» ОРИ практикой не подтверждается: бактериальные осложнения редки.

Основные возбудители

Возбудитель	Особенности
Риновирус	25–40% ОРВИ, круглый год с подъёмами весной и осенью, чаще дети до 5 лет; ринит, бронхит, провоцирует бронхообструкцию и обострения астмы; выделение вируса 5–10 дней
Аденовирус	поражает дыхательные пути, лимфоидную ткань, конъюнктиву, кишечник; устойчив во внешней среде до 2 недель; до 6 месяцев защищают материнские антитела; вспышки в коллективах
Респираторно-синцитиальный вирус	высококонтагиозен, иммунитет нестойкий; у детей до 2 лет — бронхиолит с дыхательной недостаточностью; есть пассивная иммунизация для групп риска
Метапневмовирус	от лёгких форм до бронхита, бронхиолита, пневмонии; пик зимой и ранней весной
Грипп	антигенная изменчивость; ринит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит; тяжёлое течение с пневмонией и ОРДС; есть вакцинация
Парагрипп	у маленьких детей может давать «ложный круп» (острый обструктивный ларингит); иммунитет нестойкий
Сезонные коронавирусы	до 30% сезонных ОРВИ у детей; инкубация 2–3 дня; ринит, фарингит, сухой кашель, диарея
Бокавирус	ринофарингит, иногда обструктивный бронхит, может ухудшать астму

2.3 Тяжесть

Температура не отражает тяжесть: опасные состояния бывают и без лихорадки. Главное — стратификация риска, особенно у детей с тяжёлой сопутствующей патологией.

Формы

1. лёгкая: слабая интоксикация, неяркие местные изменения;
2. среднетяжёлая: умеренная интоксикация — головная боль, слабость, снижение аппетита, возможен абдоминальный синдром;
3. тяжёлая: выраженное нарушение общего состояния, многократная рвота, изменения сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения, возможны бред, судороги.

Признаки особой тяжести: судорожный, менингеальный, геморрагический синдромы, признаки энцефалита, гипотермия.

2.4 Клиническая картина

Начало острое, чаще субфебрилитет (**37,5–38,0 °C**).

Фебрильная лихорадка характернее для

1. гриппа;
2. аденовирусной инфекции;
3. энтеровирусных инфекций.

У 82% температура снижается **на 2–3-й день**, при гриппе и аденовирусной инфекции держится **до 5–7 дней**.

Насторожиться

1. температура нарастает, признаки бактериальной интоксикации — бактериальная инфекция;
2. повторный подъём после улучшения — часто острый средний отит на фоне ринита.

1. ринофарингит: заложенность, выделения, жжение и сухость в носоглотке, стекание слизи с кашлем и чиханием; пик **на 1–3-й день**, длительность **до 6–8 дней**; при евстахеите щелчки, шум, боль в ушах, снижение слуха; у грудных — беспокойство, трудности кормления и засыпания;
2. ларингит: осиплость, грубый сухой кашель; в отличие от крупа нет стеноза и дыхательной недостаточности;
3. фарингит: гиперемия, отёчность и зернистость задней стенки глотки, непродуктивный навязчивый кашель;
4. трахеит: навязчивый изнуряющий кашель, затем влажный; **до 10–14 дней**.

---

3. Диагностика

Общепринятых критериев нет. Диагноз — по жалобам, анамнезу, осмотру и эпиданамнезу; обследование нацелено прежде всего на осложнения, тактику и маршрутизацию.

Катаральное воспаление верхних дыхательных путей, возможны

1. лихорадка;
2. чихание, кашель;
3. боль в горле, осиплость;
4. нарушение обоняния.

В анамнезе уточняют

1. контакт с больными, заболеваемость в детском учреждении, эпидемический подъём, сезон;
2. характер и длительность жалоб: недомогание, лихорадка, у грудных — отказ от груди, беспокойство; боль в горле, насморк, осиплость, кашель, лимфоузлы, боли в животе;
3. при осложнениях: одышка, сердцебиение, сильная головная боль, рвота, судороги, потеря сознания;
4. переносимость температуры, фебрильные судороги в анамнезе, динамику симптомов;
5. хронические заболевания — риск осложнений;
6. прививки (у детей **до 6 месяцев** — и вакцинацию матери), пассивную иммунизацию против РСВ у детей из групп риска.

3.1 Осмотр

Показания

1. все с подозрением на ОРВИ: кожа и слизистые, склеры, дужки и задняя стенка глотки (гиперемия, зернистость, фолликулы), миндалины, регионарные лимфоузлы.

Те же признаки бывают при стрептококковом тонзиллофарингите.

Всем

1. частота сердечных сокращений и аускультация сердца — миокардит, кардиомиопатия, эндокардит, нарушения ритма;
2. пальпация и аускультация лёгких — бронхит, бронхообструкция, пневмония;
3. осмотр и пальпация живота — поражение ЖКТ, гепатоспленомегалия (инфекционный мононуклеоз).

Пальпация и аускультация грудной клетки — уровень поражения дыхательных путей: бронхит, бронхообструкция, локальная симптоматика пневмонии.

Осмотр и пальпация живота: при аденовирусной инфекции возможны тошнота, рвота, диарея; гепатомегалия со спленомегалией или без — инфекционный мононуклеоз.

Головная боль, вялость, сонливость: проверить менингеальные симптомы — инфекции ЦНС (в том числе корь) могут начинаться с катаральных симптомов.

Лихорадка, рвота, диарея: оценить степень обезвоживания по шкале CDS. На каждый 1 °C повышения температуры потери жидкости и электролитов растут примерно на 10%.

3.2 Отоскопия

Показания

1. дети с ОРВИ, ринитом и лихорадкой: отоскопия по возможности — своевременно выявить отит.

3.3 Экспресс-тесты и ПЦР

Показания

1. подозрение на острый стрептококковый тонзиллит: экспресс-тест на БГСА в мазке из зева.

Показания

1. высокая лихорадка и подозрение на грипп: ПЦР на РНК вирусов гриппа A и B в мазке из носоглотки или иммунохроматографический экспресс-тест — для своевременного противовирусного лечения.

ПЦР выявляет вирус в среднем **до 7 дней**, максимум **до 2 недель** от начала; результат **через 4–6 часов**.

Диагноз

1. в эпидемию «грипп» можно ставить клинически;
2. без возможности этиологической диагностики — «гриппоподобное заболевание».

Селективно, чаще в стационаре: экспресс-тесты на аденовирус, РСВ, метапневмовирус, парагрипп, риновирусы, бокавирус, SARS-CoV-2 или ОТ-ПЦР в реальном времени на возбудителей ОРИ.

ПЦР мазка из носоглотки на РСВ, аденовирус, метапневмовирус, парагрипп, риновирусы, бокавирус, SARS-CoV-2.

Выявление вируса не всегда означает его роль (носительство); рутинная верификация сомнительна, нужна у иммунокомпрометированных.

3.4 Анализы крови и мочи

Показания

1. выраженные общие симптомы и лихорадка: развёрнутый общий анализ крови; в стационаре — всем.

Повышение маркеров воспаления — повод искать «немую» пневмонию, отит, инфекцию мочевых путей. Лейкопения характерна для гриппа и энтеровирусов; при РСВ возможен лимфоцитарный лейкоцитоз выше 15×10^9/л, при аденовирусе лейкоцитоз 15–20×10^9/л и выше, СРБ выше 30 мг/л. Повторять анализ после выздоровления не нужно.

Показания

1. лихорадка **выше 38 °C**, особенно без видимого очага: С-реактивный белок селективно.

Выше 50 мг/л — характернее для бактериальной инфекции (точки отсечения в литературе 40–100 мг/л); оценивать вместе с клиникой и в динамике. В первые **12 часов** лихорадки низкий СРБ бактериальную инфекцию не исключает. Прокальцитонин рутинно не показан.

Показания

1. подозрение на инфекцию мочевых путей, в том числе у лихорадящих детей без катаральных явлений: общий анализ мочи (возможно тест-полосками).

У 5–10% детей раннего возраста с инфекцией мочевых путей есть и вирусная ко-инфекция с картиной ОРВИ.

3.5 Рентгенография

Рентгенографию пазух при остром рините или ринофарингите **в первые 10–14 дней** без признаков бактериального синусита не делают: ранняя рентгенография часто показывает вирусное воспаление пазух, которое проходит само за 2 недели.

Рентгенографию и КТ лёгких каждому ребёнку с ОРВИ не выполняют — лучевая нагрузка. Усиление бронхососудистого рисунка и расширение корней — не пневмония и не показание к антибиотикам.

3.6 Пульсоксиметрия, ЭКГ, ЭЭГ

Признаки дыхательной недостаточности: пульсоксиметрия.

Подозрение на нарушения ритма или миокардит, тяжёлая и осложнённая ОРВИ, пороки сердца, кардиомиопатия или миокардит в анамнезе: ЭКГ и (или) эхокардиография.

Неврологическая симптоматика (декомпенсация фоновой патологии, афебрильные судороги, подозрение на отёк мозга, менингит, энцефалит): ЭЭГ селективно.

3.7 Консультации

Подозрение на отит или синусит: осмотр оториноларинголога.

По показаниям: невролог (нейроинфекция), детский гематолог (выраженные изменения крови, геморрагический синдром), детский кардиолог (миокардит, сердечная недостаточность).

---

4. Лечение

Важно объяснить родителям доброкачественный характер болезни, ожидаемую длительность симптомов и достаточность минимальных вмешательств. Основа — облегчение симптомов. Противовирусное лечение не входит в рутинное: оно разработано только для гриппа.

4.1 Нос и горло

Показания

1. ринит: несколько раз в день 0,9% раствор натрия хлорида (**с 2 лет**) или стерильная морская вода.

У младенцев с обильным отделяемым — аспирация слизи отсосом, затем солевой раствор; приподнятый головной конец. Гипертонические растворы могут вызывать неприятные ощущения и боль.

Заложенность носа: сосудосуживающие капли или спреи по инструкции, коротким курсом **не более 5 дней**. Системные препараты с деконгестантами крайне нежелательны.

Местные антисептики для горла (спреи, таблетки, пастилки) — селективно, с осторожностью: риск резистентности и нарушения микробиома; доказательств недостаточно.

4.2 Лихорадка

Показания

1. здоровые дети **3 месяцев и старше**: температура **выше 38,5 °C** в подмышечной впадине или **выше 39–39,5 °C** ректально;
2. **до 3 месяцев**, при хронической патологии, при дискомфорте — и при меньшей температуре.

Препараты

1. парацетамол: до 60 мг/кг в сутки, противопоказан **до 3 месяцев**;
2. ибупрофен: до 30 мг/кг в сутки, противопоказан **до 3 месяцев**.

Правила

1. первую дозу парацетамола — внутрь;
2. повторная доза — только при новом подъёме температуры, строго соблюдая интервал; курсом не давать;
3. не чередовать и не сочетать жаропонижающие;
4. ректально — только при рвоте или непереносимости приёма внутрь;
5. любая лихорадка у младенца **до 3 месяцев** требует тщательного обследования и направления к специалисту или в стационар.

Жаропонижающие вместе с антибиотиками могут маскировать неэффективность последних.

Физическое охлаждение — селективно, с осторожностью: раскрыть, обтирать водой 25–30 °C; при «белой» лихорадке не применять.

Не применяют для снижения температуры

1. «литические смеси» — гипотермия, постуральная гипотензия;
2. системные кортикостероиды — иммуносупрессия, жизнеугрожающие осложнения;
3. ацетилсалициловую кислоту;
4. нимесулид;
5. метамизол натрия рутинно — агранулоцитоз; только в исключительных случаях однократно, если нет альтернативы.

Жаропонижающие и противосудорожные для профилактики фебрильных судорог не назначают; родителей учат распознавать судороги.

Системные кортикостероиды для снижения температуры не назначают: подавляют воспалительный ответ, иммуносупрессия, при многих инфекциях — жизнеугрожающие осложнения.

Ацетилсалициловую кислоту детям для снижения температуры не применяют — высокий риск нежелательных реакций.

Нимесулид детям для снижения температуры не применяют.

Метамизол натрия рутинно не используют — риск агранулоцитоза, ранние признаки которого на фоне лихорадки могут остаться незамеченными.

Профилактика фебрильных судорог жаропонижающими или противосудорожными не рекомендуется: побочные эффекты, нет доказательств.

Показания

1. лихорадка: адекватная гидратация, прежде всего пероральными солевыми растворами для регидратации (не раствором декстрозы); при невозможности — зонд или внутривенно.

Маленьким — по 0,5–1 чайной ложке, старшим — небольшими глотками.

Требования к раствору

1. натрий 50–60 ммоль/л;
2. глюкоза менее 90 ммоль/л;
3. общая осмолярность 200–245 ммоль/л.

Суточная потребность по Holliday — Segar: до 10 кг — 100 мл/кг; 10–20 кг — 1000 мл + 50 мл на каждый кг свыше 10; более 20 кг — 1500 мл + 20 мл на каждый кг свыше 20. При тяжёлой гиповолемии — болюс сбалансированного кристаллоида 20 мл/кг за 30–60 минут, до 3 раз.

4.3 Кашель

1. противокашлевые рутинно не назначают; при сухом навязчивом кашле в исключительных случаях — бутамират, леводропропизин или преноксдиазин;
2. трахеит с трудноотделяемой мокротой: муколитики коротко и с осторожностью, особенно **до 2 лет** и при нервно-мышечных болезнях («заболачивание»);
3. муколитики и отхаркивающие не сочетают с противокашлевыми;
4. паровые ингаляции не применяют — ожоги, нет пользы;
5. системные антигистаминные не назначают — неэффективны;
6. аскорбиновую кислоту не назначают.

Муколитики (амброксол, ацетилцистеин, карбоцистеин) и отхаркивающие — селективно при трахеите с трудноотделяемой мокротой.

Отхаркивающие одновременно с противокашлевыми не назначают: подавление кашля ведёт к застою мокроты.

Паровые ингаляции детям не рекомендуются: опасность ожогов, нет доказательств пользы; ВОЗ их не рекомендует.

Системные антигистаминные при ОРВИ не назначают: не уменьшают ринит и кашель.

Аскорбиновую кислоту всем детям с ОРВИ не назначают: явного улучшения нет.

4.4 Противовирусные препараты

Показания

1. подозрение на грипп у пациентов групп риска или подтверждённый грипп A и B: в первые **24–48 часов** ингибитор нейраминидазы — осельтамивир или занамивир **с 5 лет**, по инструкции.

На вирусы без нейраминидазы не действуют. При лёгком и среднетяжёлом гриппе без факторов риска и для постконтактной профилактики не применяют. Возможны тошнота, рвота, у занамивира — бронхоспазм.

Грипп средней тяжести, в том числе у пациентов групп риска: балоксавир марбоксил, детям массой **от 20 кг** по инструкции.

Пациенты **старше 2 лет** с гриппом или ОРВИ неустановленной этиологии: умифеновир в первые 24–48 часов, селективно.

Распространённые в России противовирусные и иммуномодулирующие препараты не имеют достаточных доказательств: эффект — сокращение болезни в пределах одного дня. Рутинно не использовать, избегать полипрагмазии.

4.5 Антибиотики

Системные антибиотики не назначают — они не предотвращают, а способствуют бактериальной суперинфекции.

Без антибиотиков

1. неосложнённая ОРВИ и грипп;
2. **в первые 10–14 дней**: риносинусит, конъюнктивит, ларингит, круп, бронхит, бронхообструктивный синдром.

Могут быть показаны детям с хронической бронхолёгочной патологией (например, муковисцидозом) и иммунодефицитом — по микробиологии мокроты.

4.6 Иное лечение

Острый трахеит с трудноотделяемой мокротой: селективно препараты листьев плюща (капли с 2 лет, сироп с грудного возраста), первоцвет + тимьян (таблетки с 12 лет), плющ + тимьян (сироп с 2 лет) или другие растительные средства без противопоказаний.

Есть — по аппетиту, не заставлять; польза обильного питья сомнительна. При лихорадке выше 38 °C — пероральные солевые растворы, не раствор декстрозы. Мёд, лимон, травяные чаи — безопасная альтернатива для облегчения симптомов при отсутствии аллергии.

Гомеопатические средства для лечения ОРВИ у детей не рекомендуются — нет доказательств.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Госпитализируют

1. детей **до 3 месяцев** с фебрильной лихорадкой;
2. детей с любым опасным признаком (см. ниже);
3. детей со сложными фебрильными судорогами (**более 15 минут** и (или) повторно в течение суток) — на весь период лихорадки;
4. лихорадящих с подозрением на тяжёлую бактериальную инфекцию: вялость, отказ от еды и питья, снижение мочеотделения, геморрагическая сыпь, рвота (возможна и гипотермия);
5. с дыхательной недостаточностью;
6. с коморбидной патологией и риском декомпенсации;
7. по эпидемическим показаниям.

Опасные признаки

1. неспособность или отказ пить, сосать грудь;
2. сонливость, вялость, отсутствие контакта или резкое беспокойство;
3. респираторный дистресс: одышка, тахипноэ, втяжение уступчивых мест, кряхтящее дыхание, апноэ;
4. центральный цианоз;
5. сердечная недостаточность;
6. тяжёлое обезвоживание;
7. фебрильная лихорадка **более 4–5 суток**, не снижающаяся жаропонижающими;
8. геморрагический синдром: носовое кровотечение, прожилки крови при кашле, геморрагическая сыпь.

Дыхательная недостаточность

1. кряхтящее дыхание, раздувание крыльев носа, кивательные движения;
2. частота дыхания: **до 2 месяцев** более 60 в минуту, **2–11 месяцев** более 50, **старше 1 года** более 40;
3. втяжение нижней части грудной клетки;
4. сатурация **менее 95%** на воздухе.

Коморбидность: иммунодефицит, онкологические и гематологические болезни, нарушения свёртывания, пороки сердца и аритмии, кардиомиопатия, лёгочная гипертензия, хронические болезни лёгких, ЦНС, эндокринные (сахарный диабет 1 типа), печени, почек, ЖКТ.

1. лечение обычно амбулаторное у педиатра или инфекциониста;
2. повторный осмотр — при температуре **более 3 дней** или ухудшении;
3. ринит, ринофарингит, ларингит, трахеит без опасных признаков — без госпитализации;
4. после простых фебрильных судорог ребёнка осматривают, решение о госпитализации индивидуально;
5. в стационаре в среднем 3–7 дней.

5.2 Осложнения

1. острый синусит, чаще бактериальный: заложенность носа **более 7 дней**, вторая волна температуры, тяжесть в голове, головная боль;
2. острый средний отит: на фоне назофарингита у маленьких детей обычно **на 2–5-е сутки**, до 20–40%, но гнойный, требующий антибиотиков, — далеко не у всех;

1. острый бронхит: длительный продуктивный кашель;
2. пневмония: температура **38,0 °C и выше** **более 3 дней**; при гриппе до 12% детей;
3. бактериемия: около 1% при РСВ, 6,5% при энтеровирусах;
4. обострение хронических болезней: астмы, инфекции мочевых путей.

Без осложнений ОРВИ скоротечна, выделения из носа и кашель могут держаться 1–2 недели. Мнение, что частые ОРВИ — признак «вторичного иммунодефицита» или переходят в хронические болезни, безосновательно.

5.3 Профилактика

1. мытьё рук;
2. маски;
3. обработка поверхностей и инструментов;
4. изоляция заболевших детей;
5. проветривание.

Правила «3Р»
Руки мыть не менее 30 секунд, рот и нос закрыты маской, расстояние не менее 1,5 м.

Правила «3П»
Избегать плохо проветриваемых помещений, мест скопления людей и близко говорящих людей.

Ежегодная вакцинация против гриппа **с 6 месяцев**; вакцинация от гриппа и пневмококка снижает риск острого среднего отита. После ОРВИ прививают обычно **через неделю** после выздоровления.

Паливизумаб 15 мг/кг в/м ежемесячно, 5 инъекций — группы риска

1. дети **до 6 месяцев**, рождённые на **35-й неделе** и раньше;
2. дети **до 2 лет**, лечившиеся по поводу бронхолёгочной дисплазии в последние 6 месяцев;
3. дети **до 2 лет** с гемодинамически значимыми пороками сердца.

Также #паливизумаб — детям, рождённым до 28 недель 6 дней, **в первые 12 месяцев** жизни; после операций на сердце с искусственным кровообращением или ЭКМО — дополнительная доза; детям до 24 месяцев с врождёнными дефектами иммунитета; по решению консилиума — при тяжёлой нервно-мышечной патологии, травме ЦНС, аномалиях дыхательных путей, муковисцидозе, первичной цилиарной дискинезии, синдроме Дауна, после трансплантации.

Постконтактная профилактика: умифеновир селективно по инструкции; доказательства невысокие.

Дети с рецидивирующими респираторными инфекциями (раньше «часто болеющие»): причины — свойства возбудителей, экология, пассивное курение, атопия, хронические болезни.

1. селективно лизаты бактерий или пидотимод (**с 3 лет**);
2. достаточное потребление витамина D;
3. селективно пробиотики L. rhamnosus GG и (или) S. salivarius K12 не менее 10^9 КОЕ в сутки 3–6 месяцев;
4. рутинно не используют растительные средства, аскорбиновую кислоту, гомеопатию.

Витамин D и его аналоги — для коррекции дефицита и профилактики респираторных инфекций.

L. rhamnosus GG и S. salivarius — снижение частоты и длительности респираторных инфекций, в том числе отитов.

Растительные средства, аскорбиновая кислота и гомеопатия для профилактики рецидивирующих ОРВИ рутинно не применяются.

Реабилитация обычно не нужна; острые инфекции — противопоказание к санаторному лечению. Детям, часто болеющим ОРВИ, — селективно реабилитация и санаторно-курортное лечение; избегать курения в окружении, недосыпа, переохлаждения.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 02.09.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее сентября 2029 года
Код в рубрикаторе	25_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии; Российское общество скорой медицинской помощи
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.